



Fatigue

Par [Michael R. Wasserman](#), MD, California Association of Long Term Care Medicine (CALTCM)

Reviewed By [Glenn D. Braunstein](#), MD, Cedars-Sinai Medical Center

Vérifié/Révisé févr. 2025 | Modifié avr. 2025

La fatigue est la difficulté à initier et à maintenir l'activité en raison d'un manque d'énergie, elle est accompagnée d'un désir de se reposer. La fatigue est normale après un effort physique, un stress prolongé et la privation de sommeil.

La fatigue survient le plus souvent dans le cadre d'un complexe symptomatique, mais même quand elle est le seul ou le principal symptôme de présentation, la fatigue est l'un des symptômes les plus courants.

La fatigue peut être classée en catégories temporelles:

- Fatigue récente: de durée < 1 mois
- Fatigue prolongée: durant 1 à 6 mois
- Fatigue chronique: de durée > 6 mois

L'[encéphalomyélite myalgique/syndrome de fatigue chronique](#) est une manifestation de la fatigue chronique. La maladie systémique d'intolérance à l'effort est un autre terme utilisé pour décrire cette affection (1). Les patients qui ont un [COVID-19](#) peuvent également présenter des symptômes, notamment de la fatigue, qui durent des semaines, voire des mois (ce que l'on appelle le syndrome post-COVID-19, le COVID long ou le COVID au long cours) et qui se chevauchent considérablement avec la fatigue post-virale (également appelée syndrome de fatigue post-virale) et le syndrome de fatigue chronique (2).

Les patients peuvent désigner certains autres symptômes comme de la fatigue; un historique minutieux peut aider à différencier la fatigue d'autres symptômes, notamment:

- La [faiblesse](#), un symptôme de troubles du système nerveux ou musculaires, correspond à une force de contraction musculaire insuffisante lors d'un effort maximal. Des troubles tels que la [myasthénie grave](#) et le [syndrome d'Eaton-Lambert](#) peuvent provoquer une faiblesse simulant une fatigue.
- Une [dyspnée](#) à l'effort, un symptôme précoce de troubles cardiaques et pulmonaires, peut diminuer la tolérance à l'exercice, simulant une fatigue. Les symptômes respiratoires

peuvent généralement être mis en évidence par un interrogatoire minutieux.

- La somnolence, un symptôme des troubles causant une privation de sommeil (p. ex., [rhinite allergique](#), [reflux gastro-œsophagien](#), troubles musculo-squelettiques douloureux, [apnée du sommeil](#), troubles chroniques sévères), est une envie de dormir exceptionnellement forte. Les bâillements et l'endormissement pendant la journée sont fréquents. Les patients peuvent habituellement faire la différence entre la somnolence et la fatigue. Cependant, la privation de sommeil profond non REM (nonrapid eye movement) peut causer des douleurs musculaires et de la fatigue, et de nombreux patients souffrant de fatigue ont des troubles du sommeil, de sorte que la différenciation entre fatigue et somnolence peut être difficile.

Références

1. [Committee on the Diagnostic Criteria for Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome](#); Board on the Health of Select Populations; Institute of Medicine. *Beyond Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome: Redefining an Illness*. Washington (DC): National Academies Press (US); February 10, 2015.
2. [Unger ER, Lin JS, Wisk LE, et al](#). Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome After SARS-CoV-2 Infection. *JAMA Netw Open*. 2024;7(7):e2423555. Published 2024 Jul 1. doi:10.1001/jamanetworkopen.2024.23555

Étiologie de la fatigue

La plupart des maladies graves (et bon nombre de maladies mineures) aiguës et chroniques provoquent de la fatigue. Cependant, beaucoup d'entre elles ont d'autres manifestations plus importantes (p. ex., douleur, toux, fièvre, ictère) comme plainte initiale cause de consultation. Cette discussion se concentre sur les troubles qui peuvent se manifester principalement sous la forme d'une fatigue (1).

Les troubles les plus fréquents se manifestant principalement sous forme de fatigue récente (durée < 1 mois) sont les suivants

- [Effets indésirables des médicaments](#)
- [Anémie](#)
- Stress et/ou [dépression](#)

Les causes les plus fréquentes se manifestent principalement sous forme d'une fatigue prolongée (1 à 6 mois) sont les suivantes

- [Diabète](#)
- [Hypothyroïdie](#)
- Troubles du sommeil (p. ex., [apnée du sommeil](#))
- [Cancer](#)

Les causes les plus fréquentes qui se manifestent principalement sous forme de fatigue chronique (durée > 6 mois) sont

- [Encéphalomyélite myalgique/syndrome de fatigue chronique/maladie systémique d'intolérance à l'effort](#), fibromyalgie, fatigue idiopathique
- Syndrome de fatigue postvirale
- Affections de santé mentale (p. ex., [dépression](#)) (2)
- Médicaments

Plusieurs facteurs causent ou contribuent souvent à une plainte principale de fatigue, habituellement une fatigue prolongée ou chronique (voir tableau [Certains des facteurs contribuant fréquemment à une fatigue prolongée ou chronique](#)).

TABLEAU

Certains des facteurs contribuant fréquemment à une fatigue prolongée ou chronique

Catégorie	Exemples
Maladies chroniques	Maladie rénale chronique , maladies rhumatologiques systémiques (p. ex., artérite à cellules géantes , polyarthrite rhumatoïde , lupus érythémateux disséminé)
Médicaments ou drogues	Antidépresseurs, antihistaminiques (de 1 ^{ère} génération), antihypertenseurs, arrêt de la consommation de cocaïne (habituellement fatigue récente), diurétiques qui provoquent une hypokaliémie, relaxants musculaires, drogues récréatives, sédatifs
Troubles endocriniens	Insuffisance surrénale*, diabète , hyperthyroïdie * (généralement apathique chez la personne âgée), hypothyroïdie , insuffisance hypophysaire
Infections	Infection à cytomégalo virus , endocardite , pneumonies fongiques, hépatite , VIH/VIH à un stade avancé , mononucléose , infections parasitaires*, tuberculose , SARS , COVID-19
Affections de santé mentale	Anxiété , dépression , toxicomanie , trouble panique , trouble de somatisation
Troubles de cause inconnue	Encéphalomyélite myalgique/syndrome de fatigue chronique/maladie

Catégorie	Exemples
	systémique d'intolérance à l'effort , fibromyalgie , fatigue idiopathique
Autres causes	Anémies , cancers , déconditionnement, grossesse*, dénutrition , hypercalcémie* , sclérose en plaques , traumatisme incluant les violences domestiques
*Habituellement ne cause pas de fatigue chronique.	

Références pour l'étiologie

1. [Raizen DM, Mullington J, Anaclet C, et al.](#) Beyond the symptom: the biology of fatigue. *Sleep*. 2023;46(9):zsad069. doi:10.1093/sleep/zsad069
2. [Hanson MR.](#) The viral origin of myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome. *PLoS Pathog.* 2023;19(8):e1011523. Published 2023 Aug 17. doi:10.1371/journal.ppat.1011523

Évaluation de la fatigue

La fatigue peut être très subjective. Les patients diffèrent dans ce qu'ils considèrent comme étant de la fatigue et la façon dont ils la décrivent, et il existe peu de moyens pour confirmer objectivement la fatigue ou déterminer sa gravité. L'anamnèse et l'examen clinique se concentrent sur l'identification de manifestations subtiles de maladies sous-jacentes (en particulier les infections, des troubles endocriniens et rhumatologiques, une anémie et une dépression) qui peuvent être utilisés pour guider les essais.

Anamnèse

L'**histoire de la maladie actuelle** comprend des questions ouvertes sur ce qu'est la «fatigue», l'écoute des descriptions qui pourraient suggérer une dyspnée d'effort, une somnolence, ou une faiblesse musculaire. Les relations entre la fatigue, l'activité, le repos et le sommeil doivent être étudiées, de même que l'apparition, l'évolution temporelle et les facteurs qui augmentent ou diminuent la fatigue.

L'**examen des systèmes** doit être approfondi car les causes potentielles de la fatigue sont très nombreuses et diverses. Parmi les symptômes non spécifiques importants il y a la fièvre, la perte de poids et les sueurs nocturnes (évoque un cancer, un trouble rhumatologique ou une infection). Les antécédents menstruels des femmes en âge de procréer sont recherchés. Si aucune cause n'est évidente, les patients doivent remplir des questionnaires de dépistage des troubles de santé mentale (p. ex., dépression, anxiété, troubles liés à l'utilisation de substances, troubles somatoformes) ainsi que de la violence familiale.

La **recherche des antécédents médicaux** doit porter sur des troubles connus. L'historique complet de la consommation de médicaments doit comprendre les médicaments de prescription, en vente libre, et

les drogues récréatives.

L'**histoire sociale** doit comporter la description de l'alimentation, de l'abus de drogues et d'alcool, et des effets de la fatigue sur la qualité de vie, des relations sociales, familiales et professionnelles.

Examen clinique

Les signes vitaux sont vérifiés en cas de fièvre, de tachycardie, de tachypnée et d'hypotension (en particulier orthostatique).

L'examen général doit être particulièrement complet, et comprendre l'aspect général et l'examen du cœur, des poumons, de l'abdomen, de la tête et du cou, des seins, du rectum (dont l'examen de la prostate et la recherche de sang occulte), des organes génitaux, du foie, de la rate, des ganglions lymphatiques, des articulations et de la peau.

L'examen neurologique doit comprendre des tests, au minimum, de l'état mental, des nerfs crâniens, de l'humeur, des affects, de la force, de la masse et du tonus musculaires, des réflexes, et de la marche.

Habituellement, si la fatigue est d'apparition récente, un examen ciblé en révélera la cause. Si la fatigue est chronique, l'examen a peu de chances de révéler une cause; cependant, un examen physique approfondi peut être utile sur le plan diagnostique et constitue un moyen important d'établir une relation avec le patient.

Signes d'alarme

- Perte de poids chronique
- Fièvre ou sueurs nocturnes chroniques
- Adénopathies généralisées
- Faiblesse ou douleur musculaire
- Symptômes graves non liés de type fatigue (p. ex., hémoptysie, hématurie, dyspnée grave, ascite, confusion, idéation suicidaire)
- Implication de > 1 système d'organes (p. ex., éruption cutanée plus arthrite)
- Céphalées nouvelles ou différentes ou perte de vision, en particulier avec des douleurs musculaires, chez une personne âgée, suggérant une pseudopolyarthrite rhizomélisque et/ou une artérite à cellules géantes.

Interprétation des signes

En général, une cause est plus susceptible d'être retrouvée quand la fatigue représente l'un des nombreux symptômes que lorsque la fatigue est le seul symptôme. Une fatigue qui s'aggrave avec l'activité et diminue avec le repos suggère une affection médicale générale. La fatigue qui est présente en permanence et ne diminue pas avec le repos, en particulier avec des sursauts d'énergie occasionnels, peut indiquer une maladie mentale.

En l'absence de signes d'alarme, une anamnèse complète, l'examen clinique et des examens de laboratoire de routine (plus des tests réalisés en fonction de signes spécifiques, voir tableau [Interprétation de signes sélectionnés dans la détermination du type de fatigue](#)) doivent suffire pour une

évaluation initiale. Si les résultats des examens sont négatifs, l'attente vigilante est généralement appropriée; si la fatigue se détériore ou d'autres symptômes et signes se développent, le patient est réévalué.

Plusieurs causes peuvent être évoquées en cas de fatigue chronique ou prolongée et d'autres signes cliniques fréquents ou spécifiques sélectionnés.

TABLEAU

Interprétation de certains résultats sélectionnés dans l'évaluation de la fatigue

Symptômes	Causes possibles	Causes à évoquer*
Anorexie, douleurs abdominales, perte de poids ou stéatorrhée	Dénutrition secondaire à des troubles des voies digestives, cancer	Endoscopie, IRM de l'abdomen, cholangiopancréatographie par résonance magnétique (CPIRM)
Anorexie, douleurs abdominales, perte de poids, hypotension orthostatique, hyperpigmentation de la peau	Une insuffisance surrénalienne	Ionogramme sanguin, cortisol et taux d'ACTH; parfois test de stimulation par l'ACTH 1-24 (Cortrosyn®) synthétique
Fièvre, sueurs nocturnes, ou perte de poids	Infection, troubles rhumatologiques (y compris vascularite)	Radiographie thoracique, NFS, VS, hémocultures ou d'autres cultures, facteur rhumatoïde et AAN
Dyspnée avec toux ou hémoptysie	VIH/VIH à un stade avancé (pneumonie à <i>Pneumocystis jirovecii</i>), pneumonie fongique, tuberculose , COVID-19	Radiographie thoracique, TDM ou PET-TDM du thorax, test du VIH, cytologie et/ou culture des expectorations, tests de la fonction pulmonaire, intradermo-réaction à la tuberculine, test moléculaire ou antigénique pour le SARS-CoV-2

Symptômes	Causes possibles	Causes à évoquer*
Dyspnée, orthopnée, et/ou œdème	Insuffisance rénale chronique, insuffisance cardiaque	Radiographie thoracique, tests de la fonction rénale, échocardiographie (si orthopnée)
Dyspnée, taches de Roth, lésions de Janeway, souffles cardiaques nouveaux ou changeants, utilisation de drogues intraveineuses	Endocardite	Hémocultures sérielles, échocardiographie
Diminution de la tolérance à l'exercice avec dyspnée à l'effort, pâleur	Anémie	NFS
Adénopathies généralisées	VIH/VIH au stade avancé, leucémie, lymphome, mononucléose	Les tests sérologiques pour l'EBV, la NFS et le VIH
Association d'arthrite, d'éruptions cutanées et/ou de toute autre atteinte organique	Maladie rhumatismale systémique (y compris les vascularites)	NFS, VS, facteur rhumatoïde, anti-CCP, ANCA, AAN
Ictère, ascite, confusion	Hépatite	Tests hépatiques, sérologies de l'hépatite virale
Polydipsie, polyurie, augmentation de l'appétit, prise ou perte de poids	Diabète	Glycémie à jeun, HbA1C, hyperglycémie provoquée par voie orale
Intolérance au froid, prise de poids, constipation, peau rugueuse	Hypothyroïdie , insuffisance hypophysaire	Tests des fonctions thyroïdiennes
Perte de poids ou fibrillation auriculaire chez la personne âgée	Hyperthyroïdie (dont la forme apathique)	Tests des fonctions thyroïdiennes
Une fatigue plus importante avec l'exposition à la chaleur, des symptômes neurologiques antérieurs	Sclérose en plaques	IRM du cerveau et/ou de la moelle épinière avec contraste

Symptômes	Causes possibles	Causes à évoquer*
(p. ex., engourdissement, ataxie, faiblesse), en particulier > 1 épisode		
Céphalées, claudication de la mâchoire, douleurs ou épaississements de l'artère temporale, et/ou douleurs musculaires chez une personne âgée	Artérite à cellules géantes	VS, IRM ou TDM, biopsie de l'artère temporale
Anxiété, tristesse, anorexie, troubles du sommeil inexplicables	Anxiété, dépression, violence domestique, somatisation	Bilan clinique
Pharyngites, adénopathies et splénomégalies récentes	Mononucléose, encéphalomyélite myalgique/syndrome de fatigue chronique/maladie systémique d'intolérance à l'effort	Tests sérologiques de l'EBV; NFS, VS, TSH, examens biochimiques (comme dans le cas d'une suspicion de syndrome de fatigue chronique)
Lymphadénopathie, splénomégalie	Infection par le CMV, lymphome	Tests sérologiques pour l'EBV, parfois tests anticorps du CMV; cytométrie de flux, biopsie excisionnelle d'un ganglion lymphatique
Infections fréquentes ou opportunistes, candidose, lymphadénopathie, splénomégalie	VIH/VIH à un stade avancé	Dépistage du VIH
Douleur chronique, musculosquelettique, extra-articulaire étendue, zones gâchettes, symptômes du côlon irritable, migraines, anxiété	Fibromyalgie	VS ou protéine C réactive, TSH, sérologie de l'hépatite C
Perte de poids, stéatorrhée, prises orales inadéquates	Dénutrition, insuffisance pancréatique	Albumine plasmatique, numération des lymphocytes totaux et des

Symptômes	Causes possibles	Causes à évoquer*
		CD4, transferrine sérique, vitamine B12 sérique, fer sérique, folate sérique, mesure de l'élastase fécale
Constipation, léthargie, douleurs osseuses (p. ex., la nuit)	Hypercalcémie	Chimie sérique, dont le calcium
Malaise après l'effort, sommeil non réparateur, troubles de la concentration ou de la mémoire à court terme, intolérance orthostatique, maux de gorge, myalgies, céphalées	Encéphalomyélite myalgique/syndrome de fatigue chronique/maladie systémique d'intolérance à l'effort , fibromyalgie, fatigue idiopathique	NFS, VS, TSH, ionogramme, glycémie, calcium et tests des fonctions rénales et hépatiques
*Le choix de tests spécifiques est fonction des causes cliniquement suspectées. ACTH = hormone adrénocorticotrope; AAN = anticorps antinucléaires; ANCA = anticorps antineutrophiles cytoplasmiques (antineutrophil cytoplasmic antibodies); anti-CCP = peptide citrulliné anticyclique; NFS = numération formule sanguine; CK = créatine kinase; CMV = cytomégalovirus; EBV = virus Epstein-Barr; VS = vitesse de sédimentation érythrocytaire; CPIRM = cholangiopancréatographie par résonance magnétique; PET = tomographie par émission de positrons; TSH = thyroid-stimulating hormone.		

Examens complémentaires

Les examens visent les causes suspectées sur les signes cliniques. Si aucune cause n'est évidente ou suspectée en fonction des signes cliniques, il est peu probable que les examens de laboratoire révèlent une cause. Pourtant, de nombreux médecins recommandent de tester ce qui suit:

- Numération formule sanguine
- Ferritine
- Vitesse de sédimentation globulaire (VS)
- TSH (Thyroid-Stimulating Hormone)
- Chimies, y compris électrolytes, glucose, calcium et bilans rénaux et hépatiques

La mesure de la créatine kinase (CK) est recommandée en cas de douleur ou de faiblesse musculaire. Le test du VIH et le dépistage de la tuberculose par intradermo-réaction à la tuberculine ou des [tests de libération de l'interféron-gamma](#) sont recommandés si le patient présente des facteurs de risque. Une radiographie de thorax est recommandée en cas de [toux](#) ou de [dyspnée](#). D'autres tests, tels que ceux

visant à rechercher des infections ou des insuffisances immunologiques, sont déconseillés, sauf en cas de signes cliniques évocateurs.

Le diagnostic d'[encéphalomyélite myalgique/syndrome de fatigue chronique/maladie systémique d'intolérance à l'effort](#) nécessite des [critères diagnostiques spécifiques](#).

Traitement de la fatigue

Le traitement visant à réduire la fatigue est dirigé contre la cause.

Les patients atteints d'[encéphalomyélite myalgique/syndrome de fatigue chronique/maladie systémique d'intolérance à l'effort](#) et de fatigue chronique idiopathique sont traités de la même manière. On doit les informer clairement que l'étiologie est actuellement inconnue. Le traitement est plus souvent couronné de succès si le praticien est patient et ne porte pas de jugement et reconnaît les effets réels de la fatigue.

Il n'existe pas de traitements pharmacologiques approuvés pour l'encéphalomyélite myalgique/syndrome de fatigue chronique/maladie d'intolérance à l'effort systémique; cependant, cela ne doit pas diminuer le potentiel futur des traitements (1). Les traitements non pharmacologiques comprennent la kinésithérapie (p. ex., la thérapie d'exercices progressifs) et le soutien psychologique (p. ex., thérapie cognitivo-comportementale). Se concentrer sur l'amélioration du sommeil et soulager la douleur peut également être utile. Les objectifs comprennent le retour au travail et le maintien de niveaux d'activité normaux.

Référence pour le traitement

1. [Seton KA, Espejo-Oltra JA, Giménez-Orenga K, et al.](#) Advancing Research and Treatment: An Overview of Clinical Trials in Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome (ME/CFS) and Future Perspectives. *J Clin Med.* 2024;13(2):325. Published 2024 Jan 6. doi:10.3390/jcm13020325

Bases de gériatrie: fatigue

La fatigue est souvent le premier symptôme d'un trouble chez les personnes âgées et ne doit pas être considérée comme faisant partie du vieillissement normal. Par exemple, le premier symptôme de la [pneumonie](#) chez une personne âgée peut être la fatigue plutôt que les symptômes pulmonaires. Le premier symptôme d'autres affections, telles qu'une [maladie de Horton](#), peut également être une fatigue chez une personne âgée. Une maladie grave peut apparaître peu de temps après une fatigue subite chez le patient âgé, la cause doit en être déterminée aussi rapidement que possible.

Points clés

- La fatigue est souvent le symptôme précoce.

- La fatigue causée principalement par une affection médicale générale augmente généralement avec l'activité et diminue avec le repos.
- En l'absence de signes cliniques évocateurs, les examens de laboratoire sont peu informatifs.
- Le traitement du syndrome de fatigue chronique a plus de chances de réussir si le professionnel de la santé est patient et compréhensif.



Copyright © 2026 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, États-Unis et ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.